Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Piratini

Av. Maurício Cardoso, 150, 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 96490000 - Fone: (53)9999-82581 - tjrs.jus.br - Email: frpiratinivjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5028821-95.2023.8.21.0022/RS

AUTOR: ARIOVALDO DA ROCHA GOULARTE (ESPÓLIO)

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: MURILO DUARTE DA SILVA GOULARTE (INVENTARIANTE)

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

ESPÓLIO DE ARIOVALDO DA ROCHA GOULARTE, sucedendo o autor originário, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano material em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**. Em síntese, o autor originário, Ariovaldo da Rocha Goularte, já falecido e posteriormente substituído por seu espólio, ajuizou a presente ação pois se encontrava em estado grave de saúde, em virtude do diagnóstico de neoplasia maligna de estômago (CID C16), em estágio avançado com metástases para fígado e linfonodos regionais. Por expressa recomendação médica, necessitava fazer uso da associação dos medicamentos TRASTUZUMABE (Herzuma) e PEMBROLIZUMABE (Keytruda), com aplicações a cada 21 dias. Todavia, a operadora de saúde ré negou o fornecimento do tratamento, sob a justificativa de que a combinação medicamentosa seria "fora da bula neste contexto" (*off-label*), uma vez que a indicação seria para tratamento de primeira linha, e o autor já havia se submetido a quimioterapias prévias. Em razão da urgência e da negativa, o autor custeou a primeira aplicação do tratamento, no valor de R$ 37.191,68 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos). Ao final, requereu: a) liminarmente, a concessão da tutela de urgência para obrigar a parte ré a fornecer a imediata cobertura ao tratamento com a associação dos medicamentos prescritos, a ser realizada no Hospital Unimed Pelotas/RS; b) a condenação da parte ré ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 37.191,68 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

Foi deferida a tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento (Evento 8).

Citada, a parte ré contestou. Alegou, principalmente, que o tratamento postulado é considerado *off-label* para o estágio da patologia do autor, pois a bula do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) em associação com Trastuzumabe (Herzuma) prevê o uso para tratamento de primeira linha, e o autor já havia se submetido a esquemas prévios de quimioterapia. Sustentou que a negativa se baseia na ausência de atendimento às diretrizes da DUT 64 do Rol da ANS e que não foram apresentados documentos comprovando a eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde, recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de renome. Defendeu, assim, a licitude da negativa de cobertura (Evento 20).

Houve réplica (Evento 23).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o interesse na produção de outras provas (Eventos 25).

Diante do falecimento do autor, foi deferida a habilitação do espólio para figurar no polo ativo da ação (Evento 32).

Vieram os autos concluso.

É o relatório.

Decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possível o julgamento da lide no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, está sujeita aos princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 6º, VIII, e 51, IV, do CDC).

A documentação médica carreada aos autos demonstra que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna de estômago em estágio avançado (CID C16), com metástases. O quadro, gravíssimo, foi detalhado nos laudos e atestados médicos que indicam expressamente a necessidade da terapia combinada com os medicamentos TRASTUZUMABE e PEMBROLIZUMABE, em razão da identificação de hiperexpressão de HER2 e do esgotamento de linhas terapêuticas anteriores, com o alerta para a urgência do caso devido à perda de performance e risco de progressão da doença.

Vejamos os relatórios médicos (evento 1, LAUDO5 e evento 1, ATESTMED6):

PACIENTE

ARIOVALDO DA ROCHA GOULARTE CPF: 058.698.620-00

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima é portador de neoplasia maligna classificada sob CID10 C16 em estágio avançado. Após realização de testagem genética, identificou-se hiperexpressão de HER2 (tal alteração era desconhecida até o momento). Pacientes com tal aletração molecular apresentam benefício clínico definido com a utilização de terapia anti-HER2 (trastuzumabe). Estudo recente evidenciou que a adição de Pembrolizumabe aos esquemas terapêuticos nesta população de pacientes aumenta de forma significativa as taxas de resposta. O paciente encontra-se clinicamente frágil. Sendo assim, a realiazação de terapia com Pembrolizumabe + Tastuzumabe e quimioterapia se possível no futuro deve ser instituída de forma imediata sob risco de progressão ou morte.

Grato e à disposição,

Referência:
Lancet Oncol. 2020 Jun;21(6):821-831. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30169-8. Epub 2020 May 18

26 de Agosto de 2023

À AUDITORIA UNIMED,

Venho por meio desta informar a urgência na indicação de tratamento oncológico para o Sr. **ARIOVALDO DA ROCHA GULARTE,** 82 anos, portador para patologia classificada sob o CID C16 (neoplasia de estômago), avançado para fígado e linfonodos regionais.

O paciente vem em tratamento oncológico para doença avançada há mais de 3 anos, com respostas duradouras em linhas prévias.

Apresenta bom estado geral para a idade, porém recentemente devido a progressão de doença, está apresentando sintomas abdominais, inapetência e perda de peso, ainda discreta, porém de risco para perda de performance breve.

Apresenta em exame complementar, amplificação para o gene ERBB2, que prediz resposta ao uso do anticorpo monoclonal anti-HER2.

Foi indicado uso de trastuzumabe associado a pembrolizumabe, devido a evidência científica de melhor resultado na combinação.

Devido a idade avançada, e uso de esquemas de quimioterapia prévia, considero de risco a associação com quimioterapia no momento, motivo da indicação do tratamento proposto.

Reforço a urgência do caso, visto perda de performance iminente. e com isso pior resultado terapêutico.

Grato, a disposição

Gustavo Pereira Zenaide
Oncologia Clínica
CPF: 804.238.840-34
CREMBRO 28.697

A negativa da ré baseia-se na alegação de uso *off-label*, argumentando que a combinação medicamentosa seria indicada apenas para "tratamento de primeira linha".

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Primeiramente, a indicação para "primeira linha" refere-se ao primeiro tratamento instituído para uma condição específica. No caso dos autos, a hiperexpressão de HER2 foi uma descoberta recente, conforme laudo médico. Logo, a terapia anti-HER2 com a associação prescrita constitui, de fato, a primeira linha de tratamento para esta condição molecular recém-diagnosticada, ainda que o paciente já estivesse em tratamento para o câncer de estômago com outras abordagens.

Ademais, a própria ANVISA publicou, em 10/04/2023, a aprovação da nova indicação para o medicamento Keytruda (pembrolizumabe), conforme documento juntado pela parte autora (evento 1, OUT11):

> *"KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de primeira linha de pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica (GEJ) localmente avançado, irressecável ou metastático, HER2-positivo, em combinação com trastuzumabe e quimioterapia contendo fluoropirimidiana e platina, cujos tumores expressam PDL1 com pontuação positiva combinada (PPC) ≥ 1, conforme determinado por exame validado."*

Ainda que o médico assistente tenha optado por não associar quimioterapia em um primeiro momento, devido à idade avançada e à fragilidade clínica do paciente, a indicação da combinação de Pembrolizumabe com Trastuzumabe para a patologia em questão possui respaldo regulatório e científico.

Nesse sentido, cabe ao médico, e não à operadora do plano de saúde, definir a melhor estratégia terapêutica para o paciente, sopesando os riscos e benefícios de cada abordagem.

Portanto, a recusa da ré em cobrir o tratamento equivale a uma indevida interferência na decisão médica, limitando as opções terapêuticas de um paciente com doença grave e de cobertura contratual incontroversa.

Diante da ilicitude da negativa, o pedido de ressarcimento do valor despendido pelo autor para o custeio da primeira aplicação do tratamento é medida que se impõe.

A nota fiscal e a discriminação dos serviços anexadas aos autos (evento 1, NFISCAL10) comprovam o desembolso da quantia de R$ 37.191,68 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) para a realização do primeiro ciclo, valor que deve ser integralmente restituído pela ré, devidamente corrigido.

A procedência do pedido é, portanto, a medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para **CONDENAR** a parte ré ao pagamento de **R$ 37.191,68 (trinta e sete mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos)**, a título de danos materiais, que deve ser atualizado pelo IGP-M desde a data do desembolso (17/08/2023) e sofrer incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sucumbente a parte ré, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios do/a advogado/a da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, atualizados e acrescidos de juros de mora, a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do CPC/15.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Agendada intimação eletrônica às partes.

Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO DE LEMOS CARNEIRO MONTEIRO, Juiz de Direito**, em 13/10/2025, às 11:25:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10092700132v3** e o código CRC **b20dcf56**.